TRANSVERSAL · TR-03

Ganglions · Node-RADS

Node-RADS v1.0 (2021)
scanner et IRM · taille puis configuration

Principe : score de 1 à 5 exprimant la probabilité d'atteinte ganglionnaire maligne, en deux étapes : **1 · taille** (petit axe), puis **2 · configuration** (texture + contours + forme). On note le ganglion le plus suspect par station. Applicable au scanner et à l'IRM, pour toutes les localisations.

ÉTAPE 1 · TAILLE

Normal

- Petit axe **< 10 mm** (règle générale)
- Inguinal : **< 15 mm**
- **< 5 mm** pour : facial, parotidien, rétro-auriculaire, occipital, rétropharyngé, jugulaire antérieur, rétrocrural, cardiophrénique, mésentérique, obturateur, **mésorectal**

Augmenté

- Ni « normal » ni « bulky »
- 10–15 mm de petit axe (non mesurable au sens RECIST)
- Ou augmentation du petit axe **≥ 2 mm** par rapport à un examen antérieur

Bulky

- Plus grand diamètre **≥ 30 mm** dans n'importe quel plan
- Ou conglomérat ganglionnaire

ÉTAPE 2 · CONFIGURATION (0 À 5 POINTS)

TEXTURE	POINTS	CONTOURS	POINTS	FORME	POINTS
Homogène	0	Lisses	0	Toute forme avec **hile graisseux conservé**	0
Hétérogène	1	**Irréguliers ou flous**	1	Réniforme ou ovale sans hile graisseux	0
Nécrose focale	2			**Sphérique sans hile graisseux**	1
Nécrose étendue ou nouvelle nécrose	3				
Signe spécifique de l'entité : aspect kystique (carcinome épidermoïde HPV+, thyroïde, tumeur germinale non séminomateuse), calcifications (thyroïde), texture mucineuse	3				

Score du ganglion : **calculateur interactif Node-RADS** ↗.

SCORE FINAL

TAILLE	CONFIGURATION 0	1	2	3	≥ 4
Normale	1	2	3	4	5
Augmentée	2	3	4	5	5
Bulky	5 quelle que soit la configuration				

Signification : 1 très faible · 2 faible · 3 équivoque · 4 élevée · 5 très élevée probabilité d'atteinte. Un ganglion augmenté de taille sans anomalie morphologique reste Node-RADS 2. Grille reconstituée à partir de l'algorithme d'Elsholtz et al. (2021) : vérifier la figure 1 de l'article original pour les cas limites.

PIÈGES

Réactionnel
infection ou inflammation locale : ganglions augmentés mais homogènes, hile conservé

Mesure
petit axe sur coupe axiale ; même phase et même plan au suivi

Nécrose
ne pas confondre avec un hile graisseux ou un artefact de volume partiel

Localisation
indiquer la station selon la classification propre à l'organe (cou, médiastin, pelvis)

TRANSVERSAL · TR-03

Ganglions · Node-RADS (suite)

Node-RADS v1.0 (2021)
scanner et IRM · taille puis configuration

ATLAS VISUEL

Configuration ganglionnaire (Node-RADS)



Hile graisseux
réniforme · 0 point

Sphérique
sans hile · 1 point

Hétérogène
1 point

Nécrose focale
2 points

Nécrose étendue
3 points

Contours irréguliers
1 point

Schémas simplifiés, non à l'échelle

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Ganglions kystiques ou nécrotiques
Radiopaedia · causes et aspects
radiopaedia.org/articles/cystic-necrotic-lymph-n

Ganglions cervicaux : critères
Radiopaedia · critères radiologiques
radiopaedia.org/articles/cervical-lymph-node-met

Node-RADS 1.0 (article original)
Eur Radiol 2021 · algorithme complet
link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00330-020

Sources : Elsholtz et al., Eur Radiol 2021 – Node-RADS 1.0 – link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00330-020-07572-4.pdf